Junta de Andalucía | Consejería de Salud y Consumo | Servicio Andaluz de Salud

**COMPLEJO HOSPITALARIO UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA**



# Plan de Acogidas para Enfermeros de Nueva Incorporación en la Unidad de Cuidados Intensivos

*Eloísa Estevez Escobar (Supervisora Enfermería) Teléfono670 946 762:/746 762*
*María Ruiz Díaz (Supervisora Enfermería); Teléfono:616 660 647 / 734 504*
*María José García Vivas (Jefatura de Bloque)*
*Pilar Lara Dominguez (subdirectora de Críticos)*
***Actualizado a junio de 2026***

***1 Bienvenido a la Unidad de Cuidados Intensivos ..... 4***

***2 Estructura de la UCI del HUVV ..... 4***

**Módulos A1 y B1: ..... 5**

**Módulos A2 y B2 ..... 6**

***3 Dotación de Recursos Humanos de UCI ..... 8***

***4 Características de los pacientes de UCI ..... 9***

***5 Funciones del Enfermero de UCI ..... 11***

**5.1 AL INICIO DE TURNO ..... 11**

**5.2 DURANTE EL TURNO ..... 13**

**5.3 AL FINAL DEL TURNO ..... 16**

***6 Información de Interés ..... 17***

Ilustración 1: Plano de la Unidad de Cuidados Intensivos HUVV ..... 5
Ilustración 2: Módulo de 6 camas A1 y B1 ..... 6
Ilustración 3: Módulos de 12 camas A2 y B2 ..... 7
Ilustración 4: Imágenes de Sala de Espera de Familiares de UCI. ..... 8
Ilustración 5: Resumen visual de del trabajo diario del enfermero de UCI ..... 18
Ilustración 6: Tríptico Información UCI ..... 19
Ilustración 7: Tríptico Escuela de Familias ..... 20
Ilustración 8: Registros Diraya ..... 0
Ilustración 9: Tríptico Transfusión GRICODE ..... 0
Ilustración 10: Perfusiones Frecuentes en UCI ..... 1

# 1 Bienvenido a la Unidad de Cuidados Intensivos

Queremos darte la bienvenida a la unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen de la Victoria (**HUVV**), y ofrecerte información acerca de su estructura, dinámica y funcionamiento con el fin de hacer más fácil el proceso de adaptación

La **Unidad de Cuidados Intensivos** se define como una organización de profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, garantizando las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes graves susceptibles de recuperación que requieren soporte respiratorio o que precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o sistemas, a la vez que los pacientes complejos que precisan de soporte por fallo multiorgánico.

Son unidades dotadas de **aparataje complejo**, donde los pacientes se encuentran **monitorizados durante las 24 horas** del día y reciben **tratamientos específicos e intensivos** para su recuperación.

El control ambiental del ruido debe ser algo imprescindible, intentando alcanzar niveles de ruidos que no superen los 45 dB durante el día, los 40 dB durante la tarde y 20 dB durante la noche, tarea bastante difícil de conseguir.

# 2 Estructura de la UCI del HUVV

La UCI, es un área específica del hospital donde se atienden a los pacientes más graves que precisan de apoyo hemodinámico.

La UCI del HUVV (Figura 1) consta de 4 módulos independientes distribuidos de la siguiente manera:

- **Modulo A1**: 6 camas (3 camas en sala diáfana y 3 camas en box individuales)
- **Módulo A2**: 12 camas: 6 boxes individuales, 3 de los cuales tienen exclusa y 3 habitaciones dobles (2 camas por cada habitación)
- **Módulo B1**: 6 camas (3 camas en sala diáfana y 3 camas en box individuales)
- **Módulo B2**: 12 camas: 6 boxes individuales, 3 de los cuales tienen exclusa y 3 habitaciones dobles (2 camas por cada habitación)

Cabe señalar, que, durante todo el año, permanecen abiertas 30 camas dejando reservadas 6 camas para los periodos de alta frecuentación hospitalaria. Como podemos observar en el plano, el ala A y B son imágenes especulares si dividimos la UCI con una línea imaginaria que pase por el distribuidor central.




*Ilustración 1: Plano de la Unidad de Cuidados Intensivos HUVV*

***Módulos A1 y B1:*** La distribución de los Módulos de 6 camas es semicircular, es decir, tres camas se disponen alrededor de un mostrador que hace las funciones de zona de trabajo y donde se encuentra ubicado el monitor central el cual nos informa del estado del paciente en todo momento (ilustración 2).

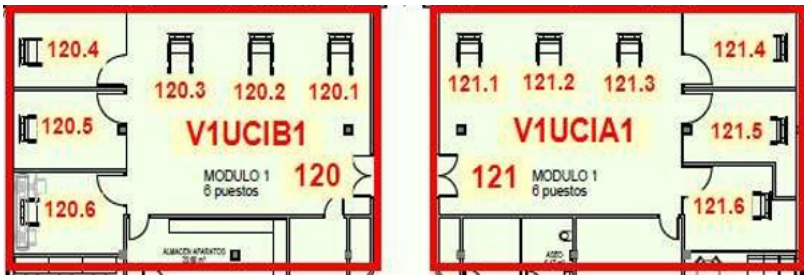



*Ilustración 2: Módulo de 6 camas A1 y B1*

La luz natural es escasa ya que los ventanales que se encuentran dentro de las habitaciones individuales tienen cristalera opaca, predominando así la luz artificial. Las camas se encuentran separadas entre sí por cortinas/biombos. Sobre cada cama se localiza el monitor de pared que está conectado con el central. Cada puesto (cama) posee una dotación de material que debe de ser revisada diariamente y repuesta en caso necesario (ver anexo XX).

Además, cada módulo está dotado de biombos portátiles para garantizar la intimidad del paciente en todo momento, durante el aseo o en la realización de pruebas donde quedan expuestos.

***Módulos A2 y B2***: La distribución de los Módulos grandes es diferente. Son más actuales y está compuesta por boxes, ya no nos encontramos esa zona central con camas alrededor. Están compuesto por 3 habitaciones (puestos) individuales con exclusa, para cuando el paciente precise de algún tipo de aislamiento, 3 habitaciones individuales sin exclusa y otras tres habitaciones dobles. En estos Módulos, la zona de trabajo está en la parte central, dividida en dos zonas, una exterior y otra interior, de manera que nos encontramos con dos monitores centrales (cada monitor para una zona del módulo).

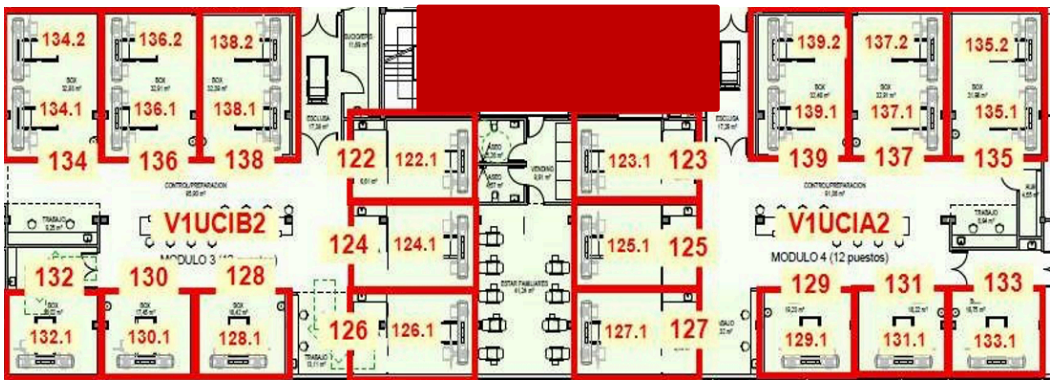



*Ilustración 3: Módulos de 12 camas A2 y B2*

Todos los Módulo, a excepción del B1 disponen de **máquinas dispensadoras de medicación (Pyxis).** Toda la medicación prescrita se volcará de forma individualizada (DMSas) para cada paciente. Los enfermeros dispondrán de claves personales para acceder a él y la trazabilidad de la prescripción, dispensación y administración de tratamiento quedará informatizada.

La unidad consta de un quirófano donde ser realiza el implante de marcapasos, tanto transitorios como definitivos (por escopia), un estar para el personal (microondas, frigoríficos, fregaderos, tostadoras y cafeteras, así como una fuente de agua), dos zonas de trabajo médicas, dos salas de información para familiares, un despacho de secretaría y un baño para el personal de UCI.

Existen alrededor de 8 áreas de almacenaje distribuidas por toda el área que ocupa la unidad, una de ellas, la más extensa ubicada en el pasillo central de la primera planta. Este gran almacén nutre a los cuatro interiores (dos en los Modulo A1 y B1 y otros dos en los Módulos A2 y B2).

La UCI tiene dos puertas de acceso, una situada en el pasillo central de la primera planta que corresponde a la entrada de personal de UCI y para el paso de pacientes y otra en el ala opuesta destinada a la entrada de familiares donde coincide con la sala de espera de familiares de UCI.




*Ilustración 4: Imágenes de Sala de Espera de Familiares de UCI.*

# 3 Dotación de Recursos Humanos de UCI

La plantilla oficial de la Unidad es de 15 Enfermeros y 5/7 TCAES para dar cobertura a los 30 puestos estructurales de UCI.

La plantilla puede sufrir variaciones en función de la ocupación y el periodo del año, intentando mantener la ratio establecida en todo momento.

La plantilla médica está formada por 25 profesionales aproximadamente incluyendo los Médicos Internos Residentes.

Junto con el personal de Enfermería (Enfermeros y TCAES) contamos con dos supervisoras de Enfermería y una jefa de servicio. El equipo lo completan celadores (tres en turno de mañana, tres en turno de tarde y uno en turno de noche), dos administrativos, tres empleadas de limpieza además de los profesionales que acuden diariamente al servicio de manera puntual para llevar a sus funciones (fisioterapeutas, técnicos de radiodiagnóstico, médicos especialistas, pinches de cocina, personal de lencería).

**Uniformidad en UCI**

La UCI cuenta con una máquina dispensadora de pijamas para los profesionales que desempeñen su labor asistencial. La activación será mediante huella dactilar y/tarjeta identificativa dando los permisos para su uso las supervisoras de Enfermería.

**Acceso a la Unidad**

La entrada a la Unidad se encuentra bajo control de acceso mediante la activación de la tarjeta identificativa general del HUVV. Esta activación será llevada a cabo por las supervisoras de Enfermería y Seguridad. Tenemos dos controles de acceso vigente, uno en la entrada de familiares y otro en la entrada de pacientes.

**Horario de Visita (ver Anexo 1)**

Existe un horario de visita flexible: A medio día de 13:30 a 14:30h, con un espacio dedicado a la información (habitualmente de dos a tres familiares) sobre el curso evolutivo del paciente. Por la tarde-noche el horario de visita es de 20:30 a 21:00h pudiendo dar información extraordinaria si la situación del paciente lo requiere. Independientemente al horario fijado de visita, los familiares podrán visitar a su familiar tras el ingreso (si el estado clínico lo permite) y recibirán información sobre su situación y pronóstico inmediato.

Por otro lado, este horario es flexible en las horas de visita y numero de familiares cuando existe limitación del soporte vital terapéutico (LSVT) con el fin de favorecer una muerte digna en UCI. De igual forma, tambien se facilita la visita a los familiares de los pacientes que cronifican su estancia por la complejidad de la enfermedad de base con el fin de favorecer su recuperación integral (físico-psiquica).

# 4 Características de los pacientes de UCI

Las características de los pacientes que ingresan en nuestra unidad son muy diversas. Se ingresan pacientes con patologías clínicas como neurológicas, gastrointestinales, respiratorias, traumatológicas, postoperatorios y con patología coronaria. La

procedencia de estos pacientes, en la mayoría de los casos provienen de los servicios de urgencias, hemodinámica, quirófano, hospitalización y otros hospitales (Figura 2).




*Figura 2: Procedencia de los Pacientes que ingresan en UCI*

En función de su enfermedad, pueden encontrarse en estado de coma inducido (sedados) o bien despiertos, como es el caso de la mayoría de los pacientes coronarios y resto con patología médica, traumatológica o postoperatoria con respiración espontánea.

Los cuidados de enfermería se realizan de forma continuada, existiendo horarios de administración de medicación, normalmente adaptada a los turnos de los profesionales, horarios de aseo, de curas, etc. (Ej.: cada 8 horas: 9-17-1 y cada 6 horas: 13-19-1-7).

# 5 Funciones del Enfermero de UCI

## *5.1 AL INICIO DE TURNO*

1. Recepción y Valoración inicial del paciente
    - Recepción estructurada del relevo (dividido por sistemas: hemodinámico, respiratorio, digestivo, neurológico…)
    - Identificación inequívoca del paciente (pulsera identificativa)
    - Identificación de riesgos activos (Inestabilidad hemodinámica, riesgo de infección, delirium…)
    - Comprobar analíticas pendientes de extracción.
2. Monitorización y Alarmas
    - Comprobación de la correcta monitorización de ECG, Sat $0_2$, TA invasiva/no invasiva, Fr
    - Ajustar límites de alarmas según la situación clínica del paciente (**Nunca desactivarlas)**
    - Verificación de la correcta colocación de sensores (BIS, NOL, TOF) y transductores de presión nivelados.
    - Realizar EKG (**Si se trata de un paciente coronario, se realizará un ECG al inicio de cada turno de diurno durante su estancia en UCI)**
3. Ventilación y Vía Aérea
    - Comprobar tipo de soporte ventilatorio
    - En soporte no invasivo, comprobar correcta conexión a oxígeno (Gafas Nasales, VMK, Reservorio, Alto Flujo o Ventilación Mecánica no invasiva)
    - En soporte invasivo, comprobar Modo ventilatorio, $Fi0_{2,}$, PEEP, volumen y presión pautados.
    - Comprobación del circuito: conexiones firmes y ausencia de condensaciones
    - Verificación de la fijación del TOT o traqueostomía.

- Medición y valoración de la presión del neumotaponamiento. Debe de estar entre 20-30 $cmH_20$ (en la unidad disponemos de medidores manuales de presión del neumotaponamiento que se encuentran ubicados en los carros de parada de cada módulo, así como medidores automáticos que se utilizan para cierto perfil de pacientes (ver PNT Prevención de la NAV)
- Cabecero elevado, lo ideal entre 30-45º (salvo contraindicación medica)
- Verificación de la existencia de una humidificación adecuada (HME o Humidificación activa)
- Aspirador comprobado y material para apertura de la vía aérea.



4. Catéter venoso central y Bacteriemia Zero
    - Inspección del punto de inserción: enrojecimiento, exudado y dolor
    - Comprobación del apósito: limpio, seco, integro y fechado.
    - Comprobación de sistemas de suero fechado (Ver tríptico de la Unidad de Cuidados Relacionados con Bacteriemia Zero)
    - Revisión de conexiones y llaves de tres pasos
    - Higiene de manos y desinfección de conexiones antes de cualquier manipulación.
5. Asignación de Medicación por luces del CVC
    - Luz Proximal: Sedoanalgesia y aminas (Noradrenalina)
    - Luz Medial: Nutrición parenteral, perfusión insulina
    - Luz Distal: Medición Presión Venosa Central, fluidoterapia y medicación intermitente (altos flujos y líquidos espesos

6. Sondaje Vesical
    - Comprobar la indicación de sondaje vesical, así como verificar que el circuito de orina se encuentra cerrado y está íntegro.
    - Comprobar que la bolsa colectora esta siempre por debajo del nivel vesical, así como cerciorarse de la ausencia de acodamientos.
    - Comprobar la correcta fijación del sondaje vesical evitando las ulceras por presión, así como evitar tracciones accidentales.
7. Medicación de Urgencias
    - Comprobar la disponibilidad de la sedación y analgesia de rescate.
    - Tener los fármacos vasoactivos preparados en caso de perfusiones continuas para su reposición.

## *5.2 DURANTE EL TURNO*

Registro y vigilancia de constantes:

Deberemos seguir un control periódico de las constantes vitales, así como una monitorización continua de modo que podamos valorar tendencias y detectar de forma precoz cualquier cambio clínico relevante. En pacientes neurológicos valoración de las características pupilares.

Glucemias: Los pacientes sedados precisan de mayor control

- Sin perfusión de Insulina y glucemias estables c/6 horas
- Con perfusión de insulina (Revisar protocolo de Insulina de la Unidad)

Manejo de Perfusiones Intravenosas y tratamiento:

- Supervisar continua de las perfusiones tanto básicas (fluidoterapia) como críticas (sedoanalgesia, aminas…).
- Revisar las dosis, velocidades y el volumen infundido con cada fármaco.

- Verificar las compatibilidades entre fármacos (ver tríptico de medicación más usada en UCI).
- Ajustar las prescripciones facultativas y dejar registrado en gráfica enfermera la administración de estas ("lo que no está registrado no está hecho")

Prevención de Infecciones

- Aplicar de Forma activa las recomendaciones de Neumonía Zero (ver PNT Prevención de la Neumonía asociada a ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos)
- Aplicar de forma activa las recomendaciones de Bacteriemia Zero (ver PNT Bacteriemia Zero)
- Aplicar de forma activa las recomendaciones de ITU Zero.

Valoración Clínica Continua: Evaluación continua del dolor, sedación, agitación, balance hídrico y función renal. Deberemos comunicar cualquier incidencia detectada con el equipo Médico.

Cuidados específicos para según el tipo de pacientes:

- Check list con cuidados específicos previo implante de marcapasos definitivo (ver en Carpeta Málaga FS).
- EKG diario en pacientes coronarios (a primera hora de la mañana)
- Ayunos en determinadas pruebas específicas.

Registro de escalas en aplicativo Diraya.

- Al ingreso
  - Valoración inicial al ingreso (Modelo UCI/Henderson). Importante indicar el cuidador principal (parentesco con el paciente y teléfono de contacto.

- Iniciar el Plan de Cuidados (Paciente UCI)
- Gráfica de Constantes (perfil a señalar: Hospitalización UCI). Registras cualquier dispositivo que tenga el paciente, vías venosas (periféricas/centrales), vías arteriales, sondas vesicales, traqueostomías, drenajes (pleurales, pericárdicos…). Importante anotar la inserción como la retirada, así como su mantenimiento y seguimiento.
- Cuestionarios/escalas: Deberemos registrar los siguientes cuestionarios durante el ingreso del paciente: Braden (riesgo de desarrollar UPP), Barthel (valorar situación basal de paciente, justo antes del ingreso), EVA y/o ESCID (valorar dolor según el nivel de conciencia del paciente) Si EVA > 3 ptos, revalorar una vez el dolor haya sido controlado.
- Registro de ITU Zero (Colocación o cambio de Sondaje vesical)
- Neumonía Zero (Medidas para la prevención de NAV).
- Detección del riesgo de Caídas (mayores de 65 años).

- Durante el Ingreso del Paciente
  - Valoración y Plan de Cuidados Semanalmente (sábados y ante cambios importantes en el estado del paciente)
  - Registro de lesiones que presente el paciente en Diraya (Lesiones relacionadas con la dependencia y otras heridas).
  - Comprobar la correcta identificación del paciente mediante la pulsera identificativa.
  - Cuestionarios y escalas: EVA o ESCID (Si EVA > 3 debe de realizarse nueva valoración cuando el dolor este controlado), Check list de Neumonía Zero, Branden, Glasgow y Maddox (Todos estos cuestionarios deberán realizarse al menos una vez en el turno)

## *5.3 AL FINAL DEL TURNO*

Antes de finalizar el turno, el enfermero responsable del paciente deberá realizar una revisión final conjunta junto con el TCAE, con el objetivo de que el paciente queda estable y correctamente atendido para el siguiente relevo.

Comprobaciones finales

- Registrar el estado clínico actual y la evolución que ha tenido durante el turno en las observaciones de enfermería de Diraya.
- Registrar constantes vitales horarias (u otro intervalo más pequeño si lo requiere el estado del paciente) dentro de la gráfica de Enfermería en papel.
- Comprobar una correcta ventilación y oxigenación del paciente.
- Comprobar perfusiones y preparadas las siguientes para su reposición.
- Comprobar el correcto estado de las vías venosas y otros dispositivos.
- Comprobar la funcionalidad y permeabilidad de los drenajes existentes.
- Comprobar la correcta administración del tratamiento prescrito.

Todo debe de quedar registrado en Gráfica de Enfermería y en las observaciones en el aplicativo Diraya. “Lo que no este escrito, no está hecho)

OTRAS CONSIDERACIONES:

1. Mantener el orden y la limpieza dentro del Box
2. Higiene de manos antes y después del contacto con el paciente
3. **SI TIENES DUDAS ¡!PREGUNTA!!...NO EXISTEN DUDAS ABSURDAS.**

# 6 Información de Interés

1. Los buscas de las Supervisoras de UCI están disponibles de lunes a viernes de **8:00 a 15:00n horas**, para cualquier incidencia que surja tras esta hora habrá que llamar al supervisor de continuada de Críticos. Teléfono: **677 90 41 42.**

2. En los escritorios de los ordenadores de todos los puestos funcionales, hay una carpeta llamada **MálagaFs** donde se encuentra toda la información de Interés de la Unidad. Podremos encontrar todos los protocolos activos de la unidad. Prestad especial interés a la infografía de la unidad.




*Ilustración 5: Resumen visual de del trabajo diario del enfermero de UCI*

### Medidas de protección

La Higiene de Manos en UCI es fundamental para prevenir infecciones. **Es obligatorio aplicar solución hidroalcohólica en sus manos a la entrada y salida de la unidad, así como el uso de la mascarilla.**

Está prohibido acercarse a otro paciente que no sea su familiar.

En el caso de pacientes con aislamiento es necesario cubrirse con bata, guantes y mascarilla. En este caso, no esta permitido el intercambio de familiares.

Le recomendamos que vaya a su domicilio a descansar. Si se queda en el hospital, permanezca en la sala de espera ubicada en la primera planta.Tiene a su disposición una ducha (solicite toalla y esponja al personal si lo precisa).

Está, terminantemente prohibido, fumar en todo el recinto hospitalario.

Red andaluza de servicios sanitarios y espacios libres de humo

### HORARIO DE INFORMACIÓN MÉDICA

**13:00-13:30 h**

### HORARIO DE VISITAS DE FAMILIARES

**13:30-14:00h.* / 20:30-21:30h.**

Tras la información, los celadores les conducirán a la cama de su familiar, desde la sala de espera. La visita será de dos familiares, y no se podrán intercambiar.

### *VISITA EXTENDIDA

Tras realizar la visita del mediodía, podrá permanecer un único familiar acompañando al paciente (que no podrá cambiarse) **hasta las 19:00**, siempre que la situación clínica del paciente y de la unidad lo permitan.

Junta de Andalucía | Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Hospital Universitario Virgen de la Victoria
Campus Universitario de Teatinos, s/n 29010 - Málaga - España
T. 951 032 000 | Fax 951 032 022 | www.huvv.es




### El Servicio de Medicina Intensiva (SMI) o Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)

Es el área del hospital donde se atienden a los pacientes más graves, que precisan de atención inmediata y vigilancia continua.

### La UCI en el Hospital Universitario Virgen de la Victoria

Está formada por 4 módulos independientes con un total, de 36 camas.

Cada paciente tiene un conjunto de dispositivos para registrar las constantes vitales y el adecuado funcionamiento de los órganos. Es habitual que se produzcan alarmas en estos dispositivos, que estarán controladas en todo momento por el personal.

Al ingreso del paciente, se le colocará una pulsera identificativa con su nombre que deberá llevar puesta durante todo el tiempo que permanezca en el hospital.

Comunique al equipo la medicación habitual de su familiar o si padece algún tipo de alergia.

Es posible que a su familiar se le realicen diferentes técnicas, algunas fuera de la unidad, por lo que serán acompañados por el personal de la UCI con las máximas garantías de seguridad.

El paciente puede estar sedado, sufrir episodios de agitación y desorientación. En todo momento, se aplicarán las medidas necesarias para asegurar su seguridad y confort.

También es normal, que puedan presentar alteraciones del sueño. Si lo necesitan, disponemos de tapones auditivos y antifaces para amortiguar el ruido y la luz.

Disponemos de apoyo espiritual.

### Información a familiares

La información es confidencial, únicamente se dará al paciente, representante legal y a los familiares autorizados y que presenten la identificación oportuna.

Los pacientes siempre tendrán un médico y un enfermero responsables.

**El médico responsable le dará la información sobre la situación clínica y evolución todos los días a partir de las 13:00, antes del horario de visita.** La información se proporcionará en el espacio habilitado para ello. En caso de que surja cualquier imprevisto o necesitemos realizarles alguna consulta, les avisaremos. Por ello necesitamos que nos faciliten algunos teléfonos de contacto.

Cuando el estado del paciente lo permita, será trasladado a hospitalización para continuar con el tratamiento. Les avisaremos del momento y la habitación a la que será trasladado.

### Consentimiento informado

En caso de que sea necesario realizar algún procedimiento especial, se solicitará la firma del consentimiento informado oral y/o escrito al paciente o, en caso de que no se encuentre capacitado, a su representante legal, que tomará las decisiones en función de los deseos del paciente.

Si el paciente dispone de un documento de Instrucciones Previas (o Voluntades Anticipadas) o desea dejar constancia de sus preferencias, comuníqueselo a su médico o enfermero responsable.

### Los familiares durante las visitas

Puede ayudar al paciente a través de mensajes positivos, transmitiéndole esperanza y tranquilidad. Si desea participar en el cuidado de su familiar, no dude en comunicárnoslo.

Todo el equipo de profesionales estamos a su disposición.

### Escuela de Familias

Desde la UCI, hemos creado la Escuela de Familias, que pretende servir de apoyo y ayuda a todas aquellas personas que tengan un familiar ingresado, proporcionando orientación acerca de cualquier tema relacionado con su familiar.

**Reunión Escuela de Familias:**
**Martes de 12 a 13 horas, sala de espera familiares UCI.**

UCI | ESCUELA DE FAMILIAS

**Secretaría de UCI _ 951 032 627**
**De lunes a jueves de 08:00 a 15:00h.**
**Viernes de 08:00 a 14:00h.**

*Ilustración 6: Tríptico Información UCI*




**1. Ingreso en la UCI**
Explicar las necesidades, el porqué y para qué del ingreso en UCI, condiciones especiales en esta unidad que permiten el tratamiento más adecuado de su familiar. Podrán solicitar apoyo, tanto emocional como en la toma de decisiones.

**2. Montorización y vigilancia**
Se explicarán las dudas existentes sobre el aparataje que acompaña al enfermo.

**3. Aseo y movilización**
Dar a conocer la importancia de realizar adecuadamente el aseo de los pacientes de forma diaria, así como de la posibilidad de repetir este aseo cada vez que se necesite. Se ofrecerá la posibilidad de colaborar, junto con el personal, en el aseo de su familiar y se darán las pautas necesarias para llevarlo a cabo. Esto aumenta el confort del paciente, ya que se siente acompañado. Se permitirá la participación de la familia en las movilizaciones del paciente, si esto es posible, y daremos nociones acerca de cómo deben realizarse estos movimientos.

**4. Dispositivos (vías, drenajes...)**
Explicar, brevemente, la función de cada uno de ellos. Explicar los riesgos que conllevan. Importante comprender la función de dichos dispositivos y porqué hemos de asumir el riesgo que conllevan.

**5. Cuidados nutricionales**
Explicaremos las necesidades nutricionales en cada momento y las diferentes formas de administrarla. El paciente presenta anorexia y la cantidad de comida ingerida es inferior a la cantidad habitual. Esto no debe preocuparles, existiendo diversos complementos nutricionales que emplearemos. Se ofrecerá la posibilidad de ayudar en el momento de la comida. Poner atención especial en el cuidado con la administración de líquidos. **Esta prohibido traer alimentos del exterior.**

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

¿QUÉ VAMOS A APRENDER?

**6. Soporte respiratorio**
Su familiar puede llevar: gafas nasales o mascarilla, que deben estar bien posicionadas. Esto puede ser insuficiente y precisar una mascarilla o un tubo conectado a un respirador, que pueden resultar un poco molestos, necesitando estar sedados, por lo que estará dormido, no podrá hablar y se alimentará a través de una sonda en su nariz o a través de una vena. También puede precisar una cánula de traqueotomía.

**7. Apoyo a su familiar**
Es probable que su familiar se ponga nervioso e incluso se agite. En las visitas, recuérdele el día y la hora que es (puede traerle un reloj, un calendario, fotos o dibujos). Asegúrese de que las barandillas de la cama están levantadas. El estado de agitación y confusión de algunos pacientes puede ser prolongado y permanecer al alta de la unidad.

**8. Atención al estado de la familia**
La enfermedad conlleva una ruptura en la rutina diaria. Esto. junto con el miedo y el desconocimiento, puede hacer que se angustien, se estresen e incluso puedan entrar en shock. Los profesionales daremos unos consejos para guiar a los familiares en estos días: la importancia del descanso correcto, adaptar su descanso a los horarios de visita...

**9. Acompañar en el fallecimiento**
En el momento en que el fallecimiento de un paciente esté próximo, daremos apoyo psicológico, emocional, asesoramiento... a cualquier familia que así lo solicite.

**10. Acompañamiento al alta**
Explicar las necesidades que pueda presentar el paciente una vez trasladado a la planta, sobre todo en los pacientes que han presentado larga estancia en UCI.

*Ilustración 7: Tríptico Escuela de Familias*

## AL INGRESO DEL PACIENTE

**VALORACIÓN INICIAL (UCI/HENDERSON)**
Indicar cuidador principal (parentesco) y tlf. de contacto
**PLAN DE CUIDADOS (PACIENTE UCI)**
**GRAFICA DE CONSTANTES (Hospitalización UCI)**

1. Registrar vías, tanto venosas como arteriales (Inserción, Seguimiento y Retirada)
2. Sonda Vesical, SNG, TOT.
3. Drenajes

**CUESTIONARIOS Y ESCALAS**

1. Glasgow
2. Braden (Riesgo de UPP)Barthel (Situación antes de ingreso)
3. EVA o ESCID (Si EVA > 3, debe de realizarse nueva valoración cuando el dolor este controlado)
4. ITU Zero (Colocación o cambio de Sonda Vesical)
5. Neumonía Zero (en VM)
6. Detección riesgo de caídas > 65 a

**SEGIMIENTO DIARIO DE LOS ACCESOS VENOSOS (PERIFÉRICOS Y CENTRALES). IMPRESCINDIBLE MADDOX DE CADA UNO DE LOS ACCESOS VASCULARES**

# UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

# REGISTROS EN DIRAYA

## AL ALTA DEL PACIENTE

**INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS:** Seleccionar **TRASLADO**. Incluir Recomendaciones

**HOJA DE TRANSFERENCIA DEL PACIENTE** (Acceso desde Estación Clínica HUVV)

**AVISAR FAMILIAR Y ACOMPAÑAR A PLANTA**

**RETIRADA DE DISPOSITIVOS** (Registrar en Diraya)

**SI EXITUS:** Pinchar en **ALTA AVANZADA**, y en DESTINO, Pinchar EXITUS.

**REVISIÓN DE CARRO DE PARADA, BOTIQUÍN Y MALETIN DE TRASLADO (Domingos)**

Junta de Andalucía | Hospital Universitario Virgen de la Victoria

## DURANTE LA ESTANCIA EN UCI

**VALORACIÓN Y PLAN DE CUIDADOS SEMANALMENTE (SÁBADOS Y ANTE CAMBIOS IMPORTANTES )**

**REGISTRO DE UPP/HERIDAS EN DIRAYA** (Seguimiento, )

**COMPROBAR PULSERA IDENTIFICATIVA**

**CUESTIONARIOS Y ESCALAS:**

1. EVA o ESCID (Si eva > 3, debe de realizarse nueva valoración cuando el dolor este controlado)
2. Neumonía Zero (en VM)
3. Braden
4. Glasgow
5. Maddox (bacteriemia zero)

**!!!!IMPORTANTE!!!!**
**"RETIRAR" DISPOSITIVOS DENTRO DE LA APLICACIÓN DIRAYA**

*Ilustración 8: Registros Diraya*

Hospital Universitario Virgen de la Victoria

# USO DE PDA PARA TRANSFUSIÓN DE HEMODERIVADOS

### 1. CONTROL DE EXTRACCIÓN DE LA MUESTRA

1.- Seleccionar Extracción muestra.
2.- Identificarnos como usuario.
3.- Leer los códigos de barra de NUHSA y NST (Gricode) por el orden que se solicitan.




Si la lectura ha sido correcta el terminal nos dará OK, pulsaremos continuar.




En caso de error aparecerá la siguiente pantalla, pulsaremos continuar y comenzaremos de nuevo el control desde el menú principal




No se puede seguir el proceso si no hay una última lectura con resultado CORRECTO.

Este paso se repite después de cada acción.

**DESCARGAR EN LA CUNA**

### 2. CONTROL DE INICIO DE TRANSFUSIÓN

Se utiliza para realizar el control de inicio de la transfusión al paciente y de la bolsa correspondiente.
1.- Seleccionar Inicio TR.
2.- Identificarnos como usuario.
3.- Leer los códigos de barra del NST (Gricode) por el orden que se solicitan:




A continuación leer el Código de Barras que identifica el producto y registrar las constantes vitales.





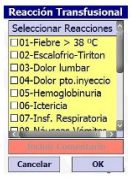


**DESCARGAR EN LA CUNA**

### 3. CONTROL DE FIN DE TRANSFUSIÓN

El proceso es exactamente igual que el Control de Inicio de transfusión, pero tras la pantalla de registro de Constantes vitales aparecerá la de resultado de la Transfusión, pudiendo ser:
1.- Transfusión OK
2.- Interrumpida
3.- Reacción Transfusional, en este caso, especificar




**DESCARGAR EN LA CUNA**




*Ilustración 9: Tríptico Transfusión GRICODE*




*Ilustración 10: Perfusiones Frecuentes en UCI*